



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نوال محمد سيد ~
 المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الجيزة
 رقم البطاقة : 26004022401266 رقم التليفون : 01112581632
 العمر (تاريخ الميلاد) : 02-04-1960 المهنة : بدون عمل
 العنوان : المنيب
 تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
 الإخصائي الاجتماعي
 التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
 التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 جهة العلاج :
 ملاحظات :
 قسم :
 نفقات :
 ملاحظات :

ختم
 شعار الجمهورية

مدير عام
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس
 المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نوال محمد سيد ~ National ID: 26004022401266	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نوال

محمد سيد فرج

عزبة القصبجي - المنيب

الجيزة - الجيزة



٢٦٠٠٤٠٢٢٤٠١٢٦٦

IX7193258



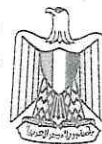
٢٠٢١/٠٦ ٢٦٠٠٤٠٢٢٤٠١٢٦٦

ربة منزل

أرملة

مسلقة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٦/٢١



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار : 2026-8-2

جهة الاصدار : فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) نوال محمد سيد بطاقة رقم 26004022401266
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-8-2



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



الخطاب ساري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او
وزارة التضامن الاجتماعي او وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

اسم المريض بالإنجليزية: Nawal Mohamed Said	كود المريض: 97758
تاريخ التقرير: 2026/08/02 12:58:40 PM	السن: ٤٦ سنة، ٢ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 65years old female patient with left breast lump and inverted nipple.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The Left breast shows lower central spiculated dense mass lesions with surrounding architectural distortion and related nipple retraction.
- **Ultrasound** revealed ill-defined irregular spiculated hypoechoic mass lesion located retroareolar opposite to 3 o'clock, measuring about 2.3 x 2 cm and about 1 cm from the overlying skin with anterior ductal extension reaching nipple measuring about 1 cm.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** Left lower central malignant mass lesion as described, Tru cut biopsy was done on the same setting.
- **Right breast (BIRADS 1):** normal study.

*Much obliged,
Dr.Esraa Elsayed
Dr.Norhan Osama*



سيجما سكان الأشعة

Pt Name: Nawal Mohamed Sayed Farag	Pt ID: 440541
Date: 28/07/2026	Pt. Age: 65 Year(s)
Procedure: Mammogram one breast	Ref Doc: Safwat Kamel Marzouk Boulos

Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With Complementary Breast US Examination Of Left Breast Revealed:

- A spiculated hyperdense lesion is seen reteroareolar at the left breast corresponding by US to a spiculated shaped heterogeneous hypoechoic solid mass lesion (taller than wider) is seen at 12 o'clock surrounded by desmoplastic reaction. The lesion shows anterior extension to the nipple causing nipple retraction. It measures about 23x17 mm with depth 15 mm from skin and 18 mm from nipple

- No suspicious enlarged lymph node at axilla, infra clavicular or supra clavicular region.

Opinion:

- Left breast reteroareolar malignant looking lesion (BIRADS V) for histopathological correlation.

Dr. Omnia Bakry MS c

28/07/2026 11:32 PM



01000103806



15076

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول
الرقمي

رسم الاستعلام 20 جنيه

جهة الاصدار: فرع الجيزة

تاريخ الاصدار: 2026-8-2

الى من يهمه الامر.....

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة الانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

والبحث تبين أن

السيد (ة) نوال محمد سيد بطاقة رقم 26004022401266

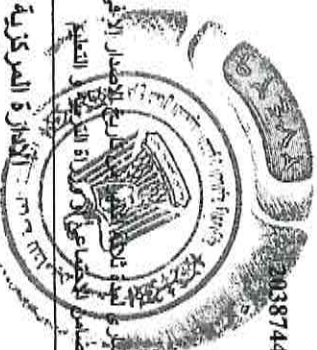
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المستفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اننى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه: 2026-8-2

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع الجيزة
ساعات محمد
إدارة النظم والمعلومات
قسم المعلومات

افادة مركز نظم المعلومات
يعتقد،،،،



مسلسل 2038744

الخطيب يبرك محمد نائبا لوزير الصحة
وزارة التضامن الاجتماعي
الاعادة المراجعة والتدقيق والتعليق

الاعادة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي القى للامراض - مصر - مصر



Patient Name	نوال محمد سيد	Case No.	345837
Sex/Age	Female 66 Y	Patient No.	25491
Registered Date	03/8/2026 02:34:35 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/8/2026 10:13:32 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	02/9/2026 11:37:10 AM	Pathology No.	2452/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 03/08/2026, at 2:34 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Multiple fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.3 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

-Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for,
-ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2).
- DCIS: Present, intermediate grade, solid.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 7%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).



غرفة رقم (4) - الدور الثاني - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Niter El Qalenna - Cairo, Egypt

Patient Name	نوال محمد سيد	Case No.	345837
Sex/Age	Female 66 Y	Patient No.	25491
Registered Date	03/8/2026 02:34:35 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/8/2026 10:13:32 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	02/9/2026 11:37:10 AM	Pathology No.	2452/26

- Her2: Low (score 1+).

- Ki67%: 7%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Maha Guinei.



خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة 3 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mivir El Qadima - Cairo, Egypt

اسم المريض بالإنجليزية: Nawal Mohamed Said	كود المريض: 97758
تاريخ التقرير: 2026/08/02 12:58:40 PM	السن: ٦٦ سنة ٢ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 65years old female patient with left breast lump and inverted nipple.

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The left breast shows lower central spiculated dense mass lesions with surrounding architectural distortion and related nipple retraction.
- **Ultrasound** revealed ill-defined irregular spiculated hypoechoic mass lesion located retroareolar opposite to 3 o'clock, measuring about 2.3 x 2 cm and about 1 cm from the overlying skin with anterior ductal extension reaching nipple measuring about 1 cm.
- Non-specific axillary LNs.

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5):** left lower central malignant mass lesion as described, tru cut biopsy was done on the same setting.
- **Right breast (BIRADS 1):** normal study.

*Much obliged,
Dr.Esraa Elsayed
Dr.Norhan Osama*